

## CAPÍTULO 13.47

## Casos de Amigdalitis

PERFIL EUNACOM 1.04.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

## Introducción a la Amigdalectomía

La **amigdalectomía** es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en la práctica otorrinolaringológica, especialmente en pediatría. Aunque tradicionalmente se asociaba casi exclusivamente a infecciones recurrentes, las indicaciones han evolucionado. Actualmente, se dividen en tres grandes grupos: **infecciosas, obstructivas y neoplásicas**.

Es fundamental recordar que la mayoría de los cuadros de amigdalitis tienden a autolimitarse o disminuir su frecuencia con el paso de los años, por lo que la decisión quirúrgica debe basarse en criterios objetivos y no en eventos aislados.

## 1. Indicaciones Infecciosas

Este grupo incluye a pacientes que sufren de infecciones bacterianas a repetición que impactan significativamente su calidad de vida.

## Amigdalitis Recurrente (Criterios de Paradise)

Para considerar la cirugía por recurrencia, se deben cumplir estrictamente los siguientes criterios de frecuencia (conocidos como la regla del 7-5-3):

**TABLA 13.47.1: PERIODO DE TIEMPO VS FRECUENCIA DE EPISODIOS BACTERIANOS**

| PERIODO DE TIEMPO     | FRECUENCIA DE EPISODIOS BACTERIANOS |
|-----------------------|-------------------------------------|
| En el último año      | 7 o más episodios                   |
| En los últimos 2 años | 5 o más episodios por año           |
| En los últimos 3 años | 3 o más episodios por año           |

## PERLA CLÍNICA EUNACOM

**Perla EUNACOM:** Para que estos episodios cuenten para la cirugía, deben ser **amigdalitis bacterianas comprobadas** (idealmente con test rápido de antígeno o cultivo para *Streptococcus pyogenes* positivo) y haber recibido tratamiento antibiótico completo y adecuado.

## Absceso Periamigdalino

El **Flegmón y Absceso Periamigdalino** es una complicación supurativa local. - La indicación quirúrgica estándar suele ser tras **2 o más episodios** de absceso periamigdalino. - Algunos especialistas consideran la cirugía tras el primer episodio si existen otros factores de riesgo o recurrencia infecciosa previa.

## Amigdalitis Crónica

Se define como una inflamación de las amígdalas que persiste por **3 meses o más**. - Se caracteriza por dolor de garganta persistente, halitosis, formación de caseum (tonsilolitos) y adenopatías cervicales. - La indicación quirúrgica surge cuando el cuadro **no responde al tratamiento médico** bien llevado (antibióticos y medidas de higiene).

## ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

**¡Cuidado!** No se debe indicar cirugía basándose solo en el relato de los padres. Los episodios deben ser documentados por un médico, verificando la presencia de exudado, adenopatías y fiebre, para asegurar que no se trata de cuadros virales banales.

## 2. Indicaciones Obstructivas

Hoy en día, las causas obstructivas son la **indicación más frecuente** de amigdalectomía (generalmente asociada a adenoidectomía). Se deben a

una **hipertrofia amigdalina** grado III o IV que genera compromiso mecánico.

- **Síndrome de Apnea/Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS):** Es la indicación principal. El paciente presenta ronquido estridente, pausas respiratorias durante el sueño, sueño fragmentado y, en niños, irritabilidad o bajo rendimiento escolar.
- **Disfagia obstructiva:** Amígdalas tan grandes que dificultan el paso del bolo alimenticio, provocando lentitud al comer o rechazo a ciertos alimentos sólidos.
- **Trastornos del lenguaje:** En raras ocasiones, la hipertrofia masiva puede causar una "voz de papa caliente" persistente.

## NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del SAHOS en niños suele ser puramente mecánica por hipertrofia del tejido linfóide (amígdalas y adenoides), a diferencia del adulto donde influyen más el colapso de la vía aérea y la obesidad. Por ello, la cirugía es altamente curativa en la población pediátrica.

## 3. Sospecha de Neoplasia

Ante la sospecha de un proceso maligno, la amigdalectomía se realiza con fines diagnósticos y terapéuticos (biopsia excisional).

- **Asimetría amigdalina significativa:** Una amígdala notablemente más grande que la otra, especialmente si presenta un crecimiento rápido o cambios en la mucosa (ulceraciones).
- **Clínica sugerente de Linfoma:** Presencia de síntomas B (fiebre, sudoración nocturna, baja de peso) asociada a aumento de volumen amigdalino asimétrico.
- **Carcinoma espinocelular:** Más común en adultos con factores de riesgo (tabaco, alcohol, VPH).

## Requisitos para la indicación quirúrgica

- Para que un paciente sea candidato a cirugía por causas infecciosas, el médico debe verificar:
- **Evaluación objetiva:** Los cuadros fueron evaluados por un profesional y no son simples resfriados virales.
- **Tratamiento antibiótico adecuado:** Se debe confirmar que el paciente completó los cursos de antibióticos (ej. 10 días de Amoxicilina).
- - Si el paciente tomó antibióticos solo por 2 o 3 días y suspendió al sentirse bien, es probable que no haya habido erradicación del **Streptococcus pyogenes**, favoreciendo la recurrencia. En este caso, la falla es del tratamiento y no necesariamente una indicación quirúrgica inmediata.

Resumen de Indicaciones (Tabla)

| TABLA 13.47.2: CATEGORÍA VS INDICACIÓN PRINCIPAL |                        |                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| CATEGORÍA                                        | INDICACIÓN PRINCIPAL   | DETALLE CLAVE                               |
| Infeciosa                                        | Amigdalitis recurrente | Criterios de Paradise (7-5-3).              |
| Infeciosa                                        | Absceso periamigdalino | Generalmente ≥ 2 episodios.                 |
| Infeciosa                                        | Amigdalitis crónica    | > 3 meses sin respuesta a tratamiento.      |
| Obstructiva                                      | SAHOS                  | Causa más frecuente actualmente.            |
| Obstructiva                                      | Disfagia               | Por hipertrofia grado III-IV.               |
| Neoplásica                                       | Sospecha de cáncer     | Asimetría amigdalina o sospecha de linfoma. |

EUNACOM CRITERIOS

Ante un paciente con amigdalitis recurrente que no cumple estrictamente los criterios de Paradise, la conducta inicial siempre debe ser la observación y el manejo médico óptimo, ya que la tendencia natural de este tejido es a la involución con la edad.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 7 años presenta fiebre alta, odinofagia, adenopatías cervicales y exudado amigdalino. Al examen se observa un exantema difuso con textura de piel de gallina, petequias lineales en fosas antecubitales y respeto de la zona nasogeniana. El hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Casos de Amigdalitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Amigdalitis viral: síntomas catarrales presentes (tos, rinorrea, disfonía), score de Centor 0-1 → tratamiento sintomático.
- Amigdalitis bacteriana: fiebre >38°C, exudado en surcos, adenopatías, sin catarro, edad 5-15 años → Centor 4-5 → antibióticos.
- Menores de 3 años con exudado amigdalino → lo más probable es adenovirus, no bacteria.
- Escarlatina: amigdalitis pultácea + exantema en piel de gallina + líneas de Pastia + triángulo de Filatov respetado + neutrofilia. Tratamiento = igual que amigdalitis pultácea.
- Kawasaki: ojo rojo + boca roja (labios partidos, lengua roja) + manos/pies rojos con edema/descamación + rash + adenopatía → ecocardiograma + aspirina + IgG IV.
- Mononucleosis: exudado blanco adherente en SUPERFICIE amigdalina + linfocitosis + esplenomegalia ± hepatomegalia ± ictericia.
- El rash morbiliforme de la mononucleosis aparece en 30% espontáneamente, pero sube a 90% tras ampicilina/amoxicilina.
- Fiebre faringoconjuntival (adenovirus): conjuntivitis + fiebre + faringitis → cuadro benigno, no requiere antibióticos.

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CASOS DE AMIGDALITIS)

## PREGUNTA 1

Niño de 7 años presenta fiebre alta, odinofagia, adenopatías cervicales y exudado amigdalino. Al examen se observa un exantema difuso con textura de piel de gallina, petequias lineales en fosas antecubitales y respeto de la zona nasogeniana. El hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A) Enfermedad de Kawasaki; aspirina más inmunoglobulina G endovenosa
- B) Mononucleosis infecciosa; tratamiento sintomático
- C) Escarlatina; penicilina benzatina o amoxicilina
- D) Sarampión; tratamiento de soporte y vitamina A
- E) Amigdalitis bacteriana complicada; amoxicilina-ácido clavulánico

## PREGUNTA 2

Adolescente de 16 años con odinofagia, fiebre y adenopatías cervicales bilaterales. Se observa exudado blanco adherente en la superficie de ambas amígdalas. El hemograma muestra linfocitosis con linfocitos atípicos. Inició amoxicilina hace 2 días y ahora presenta un rash morbiliforme generalizado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Amigdalitis bacteriana con alergia a la amoxicilina
- B) Mononucleosis infecciosa
- C) Escarlatina
- D) Faringitis por adenovirus
- E) Linfoma con compromiso amigdalino

## PREGUNTA 3

Niño de 4 años presenta fiebre de 6 días de evolución, ojo rojo bilateral no purulento, labios eritematosos y fisurados, lengua aframbuesada, edema de manos y un rash polimorfo en tronco. ¿Cuál es la conducta prioritaria?

- A) Iniciar penicilina benzatina intramuscular
- B) Solicitar monotest y hemograma para descartar mononucleosis
- C) Tratamiento sintomático y control ambulatorio
- D) Ecocardiograma, aspirina e inmunoglobulina G endovenosa
- E) Iniciar corticoides sistémicos por sospecha de vasculitis

## RESUMEN: CASOS DE AMIGDALITIS

Esta clase presenta casos clínicos que permiten diferenciar las distintas causas de cuadros faríngeos: amigdalitis viral, amigdalitis bacteriana (pultácea), escarlatina, enfermedad de Kawasaki y mononucleosis infecciosa. Cada entidad tiene claves diagnósticas específicas que se repiten en las preguntas del EUNACOM y que deben dominarse. La amigdalitis viral se identifica por síntomas catarrales (rinorrea, disfonía) y score de Centor bajo (0-1 puntos). La bacteriana se presenta con fiebre alta, adenopatías, exudado en surcos y ausencia de síntomas catarrales (4-5 puntos de Centor). En menores de 3 años con exudado, lo más probable es adenovirus aunque simule una bacteriana. La escarlatina es una complicación de la amigdalitis pultácea por *Streptococcus pyogenes* productor de toxina eritrogénica: se presenta con exantema en piel de gallina, líneas de Pastia (petequias lineales en fosas antecubitales), respeto del triángulo de Filatov (zona nasogeniana) y neutrofilia. Su tratamiento es idéntico al de la amigdalitis pultácea. La enfermedad de Kawasaki se diferencia por la presencia de ojo rojo, boca roja (labios rojos y partidos, lengua roja), edema o descamación de manos y pies, rash cutáneo y adenopatía. Requiere ecocardiograma (dilatación de arterias coronarias), aspirina e inmunoglobulina G endovenosa. La mononucleosis infecciosa (Epstein-Barr) se caracteriza por exudado blanco adherente en la superficie amigdalina (no en surcos), linfocitosis, esplenomegalia/hepatomegalia, ictericia y un rash morbiliforme que aparece hasta en el 90% de los casos tras administración de ampicilina o amoxicilina (30% espontáneamente).